

KEBIJAKAN RUMAH SAKIT
STANDAR KOMPETENSI, KENAIKAN JABATAN,
DAN KEWENANGAN TENAGA MEDIS



ROXWOOD
H O S P I T A L

Disusun oleh:
Specialist Medical Authority (SMA)

Disahkan oleh:
Direktur Rumah Sakit

1. Pendahuluan

Dokumen kebijakan ini disusun sebagai landasan dalam pengaturan standar kompetensi, pengembangan karier, serta pembagian kewenangan tenaga medis. Pengaturan ini dirancang untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang terstruktur, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga medis menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tingkat kemampuan, pengalaman klinis, serta sertifikasi yang dimiliki.

2. Ruang Lingkup

Ketentuan dalam kebijakan ini berlaku bagi seluruh tenaga medis yang terlibat dalam pelayanan klinis di rumah sakit, yang mencakup:

- Paramedic
- Co-ass (Co-Assistant)
- Dokter Umum
- Dokter Spesialis

3. Ketentuan Kenaikan Paramedic menjadi Co-ass

Peralihan jenjang dari paramedic ke posisi co-ass dilaksanakan melalui proses penilaian yang mempertimbangkan kesiapan klinis serta keterlibatan dalam kegiatan medis sebelumnya. Penilaian tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pengalaman teknis, tetapi juga pemahaman terhadap alur pelayanan pasien dan kemampuan bekerja dalam tim medis.

Sebagai dasar pertimbangan, calon co-ass diharapkan telah memenuhi kriteria berikut:

- Berpartisipasi dalam minimal 3 (tiga) kali asistensi tindakan operasi
- Memiliki pemahaman dasar mengenai alur pelayanan medis
- Memperoleh rekomendasi dari tenaga medis yang memiliki kewenangan

4. Persyaratan Kenaikan dari Co-ass menjadi Dokter

Pengangkatan co-ass ke jenjang dokter dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi klinis, tanggung jawab profesional, serta kesiapan dalam menangani pasien secara mandiri. Penilaian dilakukan berdasarkan rekam jejak praktik serta kemampuan dalam pengambilan keputusan medis.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi meliputi:

- Melaksanakan peran sebagai DPJP dalam minimal 3 (tiga) tindakan operasi minor
- Terlibat sebagai asisten dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) tindakan operasi mayor
- Mampu menyusun rekam medis secara lengkap, sistematis, dan akurat

- Memahami alur penanganan pasien secara menyeluruh, mulai dari diagnosis hingga tindak lanjut

5. Sistem Pelatihan dan Sertifikasi

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kesiapan tenaga medis, rumah sakit menerapkan sistem pelatihan berjenjang yang terintegrasi antara teori dan praktik. Program ini dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis yang memadai sebelum diberikan kewenangan klinis lebih lanjut.

Tahapan pelatihan yang harus diikuti meliputi:

- Pembelajaran teori melalui program Medical Academy
- Simulasi berbasis manekin atau studi kasus klinis
- Keterlibatan dalam asistensi tindakan medis secara langsung
- Pelaksanaan praktik klinis dengan supervisi tenaga medis berwenang

Materi pembelajaran mencakup:

- Anatomi dasar
- Teknik dasar tindakan operatif
- Prinsip sterilitas dan aseptik
- Penanganan komplikasi
- Interpretasi dasar radiologi (X-ray dan CT Scan)

Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang dimiliki, tenaga medis diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi berikut:

- Sertifikat Operasi Minor
- Sertifikat Operasi Plastik (Basic)
- Sertifikat Medical Class

6. Klasifikasi Tindakan Operatif

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan medis, tindakan operatif dikategorikan berdasarkan tingkat kompleksitas, risiko, serta kebutuhan sumber daya yang terlibat. Pengelompokan ini menjadi dasar dalam penentuan kewenangan tenaga medis dalam melakukan tindakan tertentu.

Secara umum, tindakan operatif dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- **Operasi Minor**, yang mencakup prosedur dengan risiko relatif rendah, durasi singkat, serta umumnya tidak memerlukan anestesi umum
- **Operasi Mayor**, yang melibatkan tingkat kompleksitas tinggi, risiko signifikan, serta memerlukan dukungan fasilitas dan tim medis yang lebih lengkap

Rincian lebih lanjut mengenai jenis tindakan pada masing-masing kategori tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini.

7. Kewenangan Klinis Berdasarkan Jenjang Profesi

a. Paramedic

Paramedic merupakan tenaga medis pra-rumah sakit maupun pelayanan emergensi yang berfokus pada penanganan awal, stabilisasi pasien, transportasi medis, serta dukungan tindakan klinis di fasilitas kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, paramedic wajib bekerja sesuai kompetensi, protokol kegawatdaruratan, dan kebijakan rumah sakit.

Dalam hal ini, paramedic berwenang untuk:

- Melakukan triase awal dan penilaian kondisi pasien saat kedatangan
- Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan monitoring berkala
- Melaksanakan tindakan pertolongan hidup dasar dan lanjutan sesuai kompetensi
- Menjaga jalan napas (airway management dasar), pemberian oksigen, ventilasi bantu, dan resusitasi jantung paru
- Mengendalikan perdarahan, pemasangan balut tekan, tourniquet, dan immobilisasi trauma
- Melakukan pemasangan bidai (splint), spinal immobilization, serta evakuasi pasien trauma
- Melakukan pemasangan akses intravena dan pemberian cairan sesuai protokol yang berlaku
- Melakukan transportasi medis dan rujukan pasien ke fasilitas lain
- Membantu dokter dan co-ass dalam tindakan medis maupun operatif
- Melakukan stabilisasi serta monitoring pasien saat dokter belum tersedia sesuai ketentuan rumah sakit

Paramedic tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan operasi minor maupun mayor sebagai operator utama
- Menjalankan tindakan definitif di luar kewenangan profesinya
- Mengambil keputusan operatif mandiri kecuali tindakan penyelamatan nyawa yang secara khusus diatur dalam protokol emergensi

b. Co-ass

Dalam menjalankan perannya sebagai tenaga medis dalam masa pendidikan dan pelatihan klinis, co-ass diberikan kewenangan terbatas yang disesuaikan dengan

tingkat kompetensi, sertifikasi internal, serta evaluasi rumah sakit. Seluruh tindakan wajib mengutamakan keselamatan pasien dan dilaksanakan sesuai arahan tenaga medis yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, co-ass berwenang untuk:

- Melakukan pemeriksaan awal, anamnesis, triase dasar, serta monitoring kondisi pasien
- Melakukan tindakan medis dasar dan penunjang sesuai kompetensi
- Melakukan tindakan operasi minor setelah memenuhi persyaratan sertifikasi rumah sakit dan/atau berada di bawah supervisi sesuai ketentuan
- Berpartisipasi sebagai asisten operator dalam tindakan operasi mayor
- Melakukan stabilisasi pasien gawat darurat, observasi, dan penanganan suportif sementara
- Dalam keadaan tidak tersedianya dokter, co-ass paling senior dapat menjalankan kewenangan terbatas sesuai ketentuan Emergency Exception yang berlaku

Co-ass tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan tindakan operasi mayor secara mandiri
- Menjalankan tindakan di luar kompetensi pelatihan
- Mengambil keputusan definitif pada kasus kompleks tanpa konsultasi atau supervisi apabila tersedia

c. Dokter Umum

Dokter umum memiliki tanggung jawab klinis yang lebih luas dalam pelayanan medis dan berwenang menangani kasus dengan tingkat kompleksitas rendah hingga menengah, termasuk kondisi kegawatdaruratan umum sebelum penanganan lanjutan oleh dokter spesialis.

Dalam hal ini, dokter umum berwenang untuk:

- Melakukan pemeriksaan, diagnosis awal, dan tata laksana medis umum
- Melakukan tindakan operasi minor secara mandiri sesuai standar profesi
- Melakukan tindakan bedah emergensi terbatas dalam kondisi darurat guna menyelamatkan nyawa pasien apabila dokter spesialis tidak tersedia
- Menentukan kebutuhan rawat inap, observasi, rujukan, maupun tindakan lanjutan
- Menjadi penanggung jawab klinis sementara pada saat dokter spesialis belum tersedia
- Memberikan supervisi kepada co-ass dan paramedic sesuai kewenangan

Dokter umum wajib:

- Mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan
- Melakukan koordinasi, konsultasi, atau rujukan kepada dokter spesialis apabila tersedia atau bila kasus memerlukan penanganan lanjutan

d. Dokter Spesialis

Sebagai tenaga medis dengan keahlian khusus, dokter spesialis memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan tindakan medis dan operatif sesuai bidang spesialisasinya. Dokter spesialis juga berperan dalam pengambilan keputusan klinis tingkat lanjut, supervisi, serta pembinaan tenaga medis lainnya.

Kewenangan dokter spesialis meliputi:

- Melaksanakan tindakan operasi minor dan mayor sesuai kompetensi spesialisasi
- Bertindak sebagai operator utama dalam tindakan operasi mayor dan kasus kompleks
- Menentukan diagnosis definitif serta rencana terapi lanjutan pada kasus rujukan atau kasus berat
- Memberikan supervisi kepada dokter umum, co-ass, dan paramedic dalam penanganan pasien
- Menjadi penanggung jawab utama pada kasus yang memerlukan keahlian spesialistik
- Melakukan evaluasi hasil tindakan, tindak lanjut, dan pengawasan mutu pelayanan medis

e. Ketentuan Umum

Seluruh jenjang profesi wajib:

- Menjalankan kewenangan sesuai kompetensi dan batas profesi masing-masing
- Mengutamakan keselamatan pasien dan etika pelayanan medis
- Melakukan dokumentasi rekam medis secara lengkap
- Menjalankan koordinasi antarprofesi demi kesinambungan pelayanan
- Mematuhi kebijakan rumah sakit dan ketentuan Emergency Exception yang berlaku dalam kondisi tertentu

8. Batasan dan Pengawasan Tindakan Medis

Dalam rangka menjaga mutu pelayanan serta meminimalkan risiko klinis, setiap tindakan medis harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan

dilakukan secara berjenjang guna memastikan kesesuaian antara kompetensi tenaga medis dengan tindakan yang dilakukan.

Ketentuan yang harus dipatuhi meliputi:

- Tindakan medis harus sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki
- Prosedur dengan tingkat kompleksitas tinggi wajib dilakukan di fasilitas yang memadai
- Tenaga medis yang belum mandiri harus berada dalam supervisi
- Seluruh tindakan harus terdokumentasi secara lengkap dalam rekam medis

9. Ketentuan Sertifikasi dan Tindakan Disipliner

Pemenuhan sertifikasi merupakan bagian penting dalam proses pengembangan tenaga medis. Oleh karena itu, setiap individu yang telah memperoleh peningkatan jenjang wajib memenuhi persyaratan sertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, akan diberlakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pemberian peringatan administratif
- Pelaksanaan evaluasi oleh Specialist Medical Authority (SMA)
- Penetapan keputusan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi
- Penyesuaian kembali jenjang jabatan apabila dinilai belum memenuhi standar

10. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara optimal, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Specialist Medical Authority (SMA). Proses ini mencakup penilaian terhadap kompetensi, kinerja, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan medis yang berlaku.

11. Penutup

Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, diharapkan tercipta sistem pelayanan kesehatan yang profesional, terstandarisasi, dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas pelayanan pasien.

LAMPIRAN I

KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI MINOR

Operasi minor merupakan tindakan medis atau bedah dengan tingkat risiko rendah, durasi relatif singkat, kompleksitas rendah, serta umumnya tidak memerlukan anestesi umum. Tindakan kategori ini dapat dilakukan oleh co-ass setelah memenuhi persyaratan sertifikasi, kompetensi klinis, dan ketentuan supervisi rumah sakit.

1. Kriteria Umum Operasi Minor

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai operasi minor apabila memenuhi sebagian besar ketentuan berikut:

- Durasi tindakan relatif singkat
- Tidak memerlukan pembukaan rongga tubuh mayor
- Risiko perdarahan rendah sampai sedang
- Tidak memerlukan perawatan intensif pascatindakan
- Pemulihan relatif cepat
- Dapat dilakukan dengan anestesi lokal
- Kondisi pasien stabil

2. Parameter Klinis Pasien

Glasgow Coma Scale

Pasien layak ditangani dalam kategori minor apabila:

- GCS 15 dan stabil
- GCS 14 dapat dipertimbangkan bila membaik cepat tanpa tanda bahaya
- $GCS \leq 13$ wajib evaluasi dokter

Tanda vital:

- Tekanan darah stabil
- Nadi adekuat
- Saturasi oksigen baik
- Tidak sesak napas
- Tidak dalam keadaan syok

3. Jenis Tindakan Operasi Minor

a. Luka Memar

- Memar lokal ringan sampai sedang

- Bengkak terbatas
- Tidak terdapat deformitas tulang
- Tidak dicurigai perdarahan internal

b. Luka Robek

- Luka superfisial atau sedang
- Perdarahan dapat dikendalikan
- Tidak mengenai tendon, saraf besar, pembuluh darah besar, atau organ vital

c. Patah Tulang Ringan

- Fraktur tertutup sederhana
- Tidak terdapat pergeseran berat
- Tidak terbuka
- Sirkulasi dan saraf distal baik

d. Luka Tembak Ringan

- Luka gores / superficial wound
- Tidak menembus rongga tubuh
- Tidak mengenai kepala, dada, atau abdomen
- Perdarahan ringan dan terkontrol

e. Luka Bakar Ringan

- Derajat 1 sampai derajat 2 superfisial
- Luas luka kecil dan terbatas
- Tidak mengenai jalan napas atau area vital luas

f. Cedera Kepala Ringan

- Luka luar kepala ringan
- GCS 15
- Tidak muntah berulang
- Tidak kejang
- Tidak terdapat defisit neurologis

4. Tindakan Minor Tambahan

- Insisi dan drainase abses kecil
- Eksisi kista kecil superfisial
- Ekstraksi benda asing superfisial
- Debridement luka ringan
- Dressing luka rutin

- Perawatan kuku tumbuh ke dalam

5. Kriteria Eskalasi Menjadi Kasus Mayor

Kasus minor wajib dinaikkan evaluasi dokter apabila terdapat:

- $GCS \leq 13$
- Perdarahan aktif berat
- Syok
- Sesak napas
- Fraktur kompleks / terbuka
- Nyeri berat tidak terkontrol
- Penurunan kondisi umum
- Multiple trauma

LAMPIRAN II

KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI MAYOR

Tindakan operasi mayor merupakan prosedur bedah dengan tingkat kompleksitas dan risiko tinggi yang umumnya memerlukan anestesi umum atau regional, ruang operasi lengkap, serta keterlibatan tim medis multidisiplin.

1. Kriteria Operasi Mayor

- Membuka rongga tubuh mayor
- Risiko perdarahan sedang-tinggi
- Membutuhkan anestesi umum/regional
- Membutuhkan rawat inap / ICU
- Durasi tindakan sedang-panjang
- Risiko komplikasi lebih tinggi

2. Jenis Kasus Mayor

a. Bedah Umum

Tindakan bedah pada organ intraabdomen dan saluran pencernaan, antara lain:

- Laparotomi eksplorasi
- Appendektomi dengan komplikasi (perforasi)
- Kolesistektomi
- Reseksi usus
- Hemikolektomi (Hemicolectomy)
- Gastrektomi
- Penanganan perforasi usus
- Penanganan ileus atau obstruksi usus
- Hernia strangulata

Subspesialis Hepatobilier dan Pankreas:

- Hepatektomi
- Prosedur Whipple (pancreaticoduodenectomy)
- Splenektomi

b. Bedah Saraf (Neurosurgery)

Tindakan pada sistem saraf pusat dan tulang belakang, meliputi:

- Craniotomy
- Evakuasi hematoma intrakranial
- Operasi tumor otak
- Operasi aneurisma serebral
- Operasi tulang belakang (spinal surgery)

c. Bedah Kardiotoraks

Tindakan pada organ jantung dan paru, antara lain:

1. Bedah Jantung:

- Coronary Artery Bypass Graft (CABG)
- Operasi katup jantung
- Transplantasi jantung

2. Bedah Paru:

- Lobektomi
- Pneumonektomi
- Operasi tumor paru

d. Obstetri dan Ginekologi

Tindakan bedah pada sistem reproduksi wanita, meliputi:

- Sectio Caesarea
- Histerektomi
- Operasi kehamilan ektopik
- Operasi tumor ovarium ukuran besar
- Myomektomi

e. Bedah Ortopedi

Tindakan pada sistem muskuloskeletal, antara lain:

- Open Reduction Internal Fixation (ORIF)

- Total Knee Replacement (TKR)
- Total Hip Replacement (THR)
- Amputasi ekstremitas
- Penanganan fraktur kompleks

f. Urologi

Tindakan pada sistem saluran kemih dan reproduksi pria, meliputi:

- Nefrektomi
- Prostatektomi
- Operasi tumor kandung kemih
- Pyeloplasty

g. Bedah Plastik dan Rekonstruksi

Tindakan rekonstruksi jaringan dengan kompleksitas tinggi, antara lain:

- Rekonstruksi wajah skala besar
- Skin graft luas
- Flap surgery
- Penanganan luka bakar berat

h. Bedah Onkologi

Tindakan pengangkatan tumor ganas atau jinak dengan kompleksitas tinggi, meliputi:

- Mastektomi
- Reseksi tumor besar
- Diseksi kelenjar getah bening
- Debulking tumor

i. Bedah Trauma (Emergensi)

Tindakan bedah pada kasus kegawatdaruratan akibat trauma, antara lain:

- Eksplorasi luka tembak
- Laparotomi trauma
- Craniotomy akibat trauma

- Thoracotomy
- Penanganan perdarahan internal

j. Bedah Vaskular

Tindakan pada sistem pembuluh darah, meliputi:

- Bypass pembuluh darah
- Operasi aneurisma aorta
- Endarterektomi

Ketentuan Tambahan

- Daftar tindakan di atas tidak bersifat terbatas dan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran.
- Penetapan klasifikasi akhir suatu tindakan sebagai operasi mayor ditentukan oleh dokter spesialis dan/atau Specialist Medical Authority (SMA) berdasarkan tingkat kompleksitas, risiko, serta kebutuhan sumber daya medis.

LAMPIRAN III

KETENTUAN PENANGANAN PASIEN SAAT TIDAK ADA DOKTER BERTUGAS

Dalam keadaan tidak terdapat dokter umum maupun dokter spesialis yang sedang bertugas, pelayanan medis tetap wajib berjalan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan batas kewenangan profesi.

1. Prioritas Pertama: Stabilisasi dan Monitoring

ABCDE approach

Co-ass dan/atau paramedic wajib melakukan:

- Menjaga jalan napas
- Menilai pernapasan
- Mengendalikan perdarahan
- Pemasangan oksigen
- Akses intravena dan cairan
- Monitoring tanda vital berkala
- Penilaian GCS serial
- Penanganan suportif

2. Prioritas Kedua: Rujukan

Pasien yang memerlukan dokter wajib diupayakan rujukan ke fasilitas lain yang tersedia, termasuk RS Alta atau rumah sakit aktif lainnya.

Surat rujukan sekurang-kurangnya memuat:

- Identitas pasien
- Keluhan utama / diagnosis kerja
- Kondisi klinis
- Tanda vital terakhir
- Tindakan yang telah diberikan
- Alasan rujukan

3. Apabila Rujukan Tidak Tersedia

Pasien dapat ditempatkan sementara di:

- Ruang rawat inap
- ICU
- Ruang observasi

Dengan monitoring ketat sampai dokter tersedia.

4. *Emergency Exception* oleh Co-ass

Apabila:

- Dokter tidak tersedia
- Rujukan tidak memungkinkan
- Penundaan tindakan berisiko menyebabkan kematian atau perburukan berat

Maka co-ass dapat melakukan tindakan penyelamatan nyawa terbatas sesuai kompetensi.

Tindakan meliputi:

- Kontrol perdarahan aktif
- Packing luka trauma
- Resusitasi
- Tindakan airway emergensi
- Chest tube emergensi bila kompeten

5. Ketentuan Intubasi Darurat

Endotracheal intubation

Intubasi dapat dilakukan oleh co-ass senior atau paramedic tersertifikasi apabila:

- GCS ≤ 8
- Henti napas
- Gagal napas
- Obstruksi jalan napas
- Aspirasi berat

Wajib dilakukan dokumentasi lengkap dan monitoring lanjutan.

6. Ketentuan Anestesi Darurat

General anesthesia

Dalam kondisi tidak ada dokter:

- Diperbolehkan:
 - Anestesi lokal
 - Sedasi ringan terbatas sesuai kompetensi

- Tidak diperbolehkan secara mandiri:
 - General anesthesia penuh elektif
 - Spinal anesthesia
 - Regional block kompleks

7. Kasus yang Tetap Wajib Menunggu Dokter / Spesialis

- Operasi Craniotomy
- Perdarahan otak definitif
- Trauma multipel kompleks
- Laparotomi kompleks
- Bedah jantung mayor
- Rekonstruksi mayor

Pada kasus tersebut hanya dilakukan stabilisasi, monitoring, dan rawat inap sementara.

8. Dokumentasi

Setiap tindakan wajib dicatat dalam rekam medis, meliputi:

- Tidak tersedianya dokter
- Upaya rujukan
- Kondisi pasien
- Tindakan yang diberikan
- Perkembangan pasien
- Nama petugas yang menangani

PENGESAHAN

Ditetapkan di : Roxwood

Tanggal : 14 April 2026

Direktur Rumah Sakit

Specialist Medical Authority (SMA)

(dr. Ryeo Haruu Ravenscroft, Sp. M)

(dr. Chocho Arata, Sp. OG)